

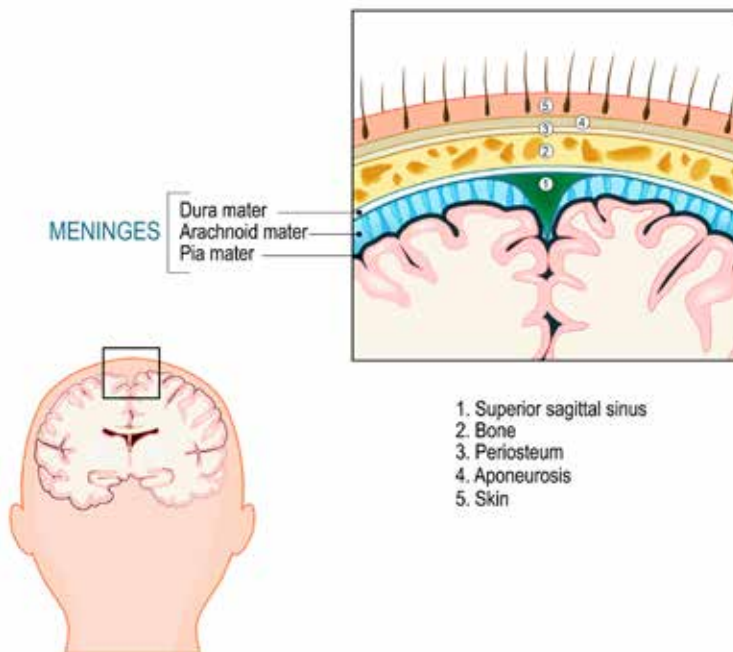
הקדמה

שיעורי התמותה מפגיעות ראש בינוניות וקשות הם 10% ו-30% בהתאמה. מאלו ששרדו מפגיעת ראש בינונית או קשה, מעל מחצית נשארו עם פגיעה נוירולוגית כלשהי. תאונות דרכים הן הגורם העיקרי לפגיעות ראש אצל אנשים מתחת לגיל 65, ונפילות הן הגורם העיקרי לפגיעות ראש אצל קשישים.

פגיעות ראש נחשבות לפציעות הקשות ביותר לטיפול. אנשים עם פגיעת ראש עלולים שלא לשתף פעולה ולהיות תוקפניים. כמו כן ייתכנו תגובות כמו הקאות או נעילת לסתות שיקשו לבצע אינטובציה (צנרר). לעיתים צריכת אלכוהול או סמים או מצב של הלם עקב פגיעות אחרות עלולים להקשות על המטפל להעריך את מצב הנפגע. טעות באבחון יכולה לקרות גם אם יש פגיעה תוך-גולגולתית חמורה המתבטאת בפציעה חיצונית קלה למדי.

לחץ תוך-גולגולתי (Intra Cranial Pressure: ICP)

הכרת האנטומיה של הראש והמוחות היא הכרחית להבנת הפתופיזיולוגיה של פגיעות ראש. הקרקפת היא השכבה החיצונית ביותר המכסה את הראש, ושכבת עור זו מספקת הגנה מועטה לגולגולת ולמוח. הקרקפת בנויה מכמה שכבות שכוללת עור, רקמת חיבור ופריאוסטאום (periosteum) של הגולגולת (איור 13.1). הת-קרחות ותהליך ההזדקנות יכולים לגרום לקרקפת להיות דקה יותר ובכך להקטין את ההגנה שהיא מספקת. עור הקרקפת והרקמה הרכה שעוטפת את הפנים עשירים בכלי דם, ופצעים קטנים ושטחיים עלולים לגרום לדימום רב שאפשר להשתלט עליו על ידי הפעלת לחץ ישיר על אזור הדימום.



איור 13.1 תיאור סכמטי של שכבות הגולגולת